

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	氣管內管照護評核表	編 號	A31000-Q07-F-021
	制定 單位		版 本	第 2.3 版
		護理部	修正日期	106 年 10 月 9 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：各加護單位護理人員。

二、評核方式：

1. 實地觀察及查核氣管內管照護情形。
2. 請單位護理人員回答相關問題。

三、評核內容：

1. 實地觀察

- a. 每日及必要時更換氣管內管宜拉膠帶或移動氣管內管固定器位置，並標示更換日期、管路大小及固定公分數。
- b. 口咬器與氣管內管兩者分別固定黏貼。
- c. 氣管內管固定方式適當：自拔管傾向者使用頸後環繞固定法；意識昏迷、肢體無力的病人使用臉頰黏貼固定法。

d. 適當支托及固定呼吸器管路，避免拉扯：

(1) 管路擺置胸部以上或保持離手腕或手肘上至少20公分處。

(2) 管路需放置床欄下緣，避免呈現U型迴路造成管路積水。

e. 呼吸器管路積水未超過管徑1/2。

- f. 維持呼吸道通暢：氣管內管內無痰液積存（目視或聽到明顯痰音則予扣分）。
- g. 意識清醒病人，叫人鈴置於病人手可按鈴位置或提供溝通工具。
- h. 約束適當（約束工具選擇、鬆緊度、約束帶綁於床體）。

2. 請單位護理人員回答相關問題：

- a. 可說出呼吸器脫離時機兩項（如：WEANSNOW）。
- b. 可回答出氣囊適當壓力：建議為20-30 cm H₂O，因臨床病人的氣管狀況有所調整，目前臨床大部分病人約22-26 cm H₂O。
- c. 可說出預防滑脫方式兩項（提供紙筆或其他工具溝通、做治療與處置前向病人說明；向病人及家屬解釋氣管內管重要性與自拔之危險；離開病人單位至它床治療時，需檢視確認約束合宜至少每兩小時解開約束予翻身擺位；離開時間較久應交班給其他同仁照護；醫療團隊需每日評估拔管適當時機）。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容												正確率 (%)	備註
			1a	1b	1c	1d(1)	1d(2)	1e	1f	1g	1h	2a	2b	2c		

註： 1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 表示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%